

临床医师诊疗丛书

名誉总主编 夏穗生 黄光英
总 主 编 陈安民 徐永健

妇产科疾病诊疗指南

(第二版)

主 编 马 丁 鲁秋云

科 学 出 版 社

北 京

内 容 简 介

全书分总论、妇产科疾病、妇产科手术、计划生育、妇产科特殊治疗共五篇内容，在系统介绍妇产科常见病、多发病的病因、诊断和治疗细则的同时，也重点介绍了妇产科特有的专科检测手段、诊断技术和治疗方法。全书编写以现代性、实用性为特色，对妇产科临床医师有较重要的参考价值。

图书在版编目(CIP)数据

妇产科疾病诊疗指南 / 马丁, 鲁秋云主编. —2 版. 北京: 科学出版社, 2005.5

(临床医师诊疗丛书 / 陈安民, 徐永健总主编)

ISBN 7-03-013180-0

I. 妇… II. ①马… ②鲁… III. ①妇科病—诊疗 ②产科病—诊疗 IV. R71

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 034914 号

责任编辑: 农 芳 黄 敏 李国红 / 责任校对: 包志虹

责任印制: 刘士平 / 封面设计: 陈 敬 黄华斌

版权所有, 违者必究。未经本社许可, 数字图书馆不得使用

出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

1999 年 7 月第 一 版 开本: 787×960 1/32

2005 年 5 月第 二 版 印张: 20 1/4

2005 年 5 月第三次印刷 字数: 542 000

印数: 8 101—13 100

定价: 29.80 元

(如有印装质量问题, 我社负责调换〈环伟〉)

临床医师诊疗丛书

名誉总主编 夏穗生 黄光英
总 主 编 陈安民 徐永健

《妇产科疾病诊疗指南》 (第二版) 编写人员

主 编	马 丁	鲁秋云		
副 主 编	乔福元	章汉旺	钟 刚	
编 者	(按姓氏笔画排序)			
	马 丁	王世宣	王常玉	邓东锐
	冯 玲	艾继辉	刘丽江	刘海意
	乔福元	朱桂金	朱树香	朱 涛
	成文彩	李科珍	李 敏	李 静
	李豫峰	何福仙	张玉兰	张 萍
	邱艾芝	陈 雯	陈汉平	陈迪文
	陈素华	陈庭惠	杨婉华	郑红兵
	武小文	岳 静	钟 刚	施 维
	原本旭	钱小虎	袁永群	黄引萍
	章汉旺	鲁秋云	曾万江	曾桂兰
	蒋吴蓉	彭兆丽	彭雪琴	靳 镭
	蔡 敏	黎 宁	濮德敏	

第一版序言

临床医学参考书籍可谓浩如烟海。从大型的学术专著到简明的临床应用手册,内容和形式层出不穷。然而对大多数工作在临床一线的中青年医师来说,尚缺一类便携式专科参考书。这类书在内容上应介乎前述两类参考书之间,既不像大型学术专著那样从基础到临床,庞杂繁复,查阅不便,又不至于像综合性的临床手册过于简单,不能满足临床诊断治疗细则的需要。有鉴于此,我们组织各临床专业科室的专家编撰了这套《临床医师诊疗丛书》。

同济医科大学建校已近百年,一直是国家卫生部直属重点高等医科院校。同济医院是同济医科大学的附属医院,为卫生部第一批评定的三级甲等医院,也是全国文明窗口十家示范医院之一。我们编撰这套《临床医师诊疗丛书》是以这所综合性大型教学医院多年来不断修订的临床诊疗常规为依据,博采各临床专业专家学者们的经验及心得,集临床医学精髓之大成,以现代性、实用性为特色,面向临床一线专业医师和技术人员。

全书由 32 个分册组成,包括 26 个临床医学二、三级专业学科和 6 个临床诊疗辅助专业分册。各分册结合综合性医院的诊疗常规,自临床的一般性问题到专科性疾病,从病因、病理至诊断、治疗,从常用的诊疗技术到高新专科手术及疗法,层次分明地予以阐述,重点在于实用性强的临床诊断、鉴别诊断及治疗方式、方法。

我们的目的及愿望是既为综合性大型医院提供一

套全面系统的诊疗常规参考书,又能为临床主治医师、住院医师、研究生、实习医师奉献一套“新、全、实用”的“口袋”书。

全书编写历经一年,全体参编人员付出了艰辛的劳动,经过科学出版社编辑同志们的精心雕琢,全书各分册得以先后面世,我们谨对上述同仁的勤奋工作致以衷心的感谢。本书参编人员达数百人之多,故文笔文风殊难一致;限于编写者的水平,加之时间紧迫,疏误之处在所难免,祈望读者不吝赐教,以便再版时予以订正。

夏穗生 黄光英 张良华

同济医科大学附属同济医院

1998年9月

第二版前言

《临床医师诊疗丛书》1999年出版了第一版,共32个分册,本次对32个分册进行了全面的修改,另外增加了“老年疾病诊疗指南、临床病理诊断指南、临床护理指南”三个分册。第二版共35个分册,保持了第一版的编写风格,重在临床“使用方便”四字。本次修改过程中,突出了近几年来疾病诊断与治疗的一些新理论、新技术、新方法。

本书自出版以来,受到了广大读者的欢迎。各个分册都进行了重印,不少分册多次重印。我们感谢大家对本书的厚爱,同时也恳求广大读者再次提出宝贵意见,以便再版时修正。编委会对原总主编夏穗生、黄光英、张良华三位教授对本丛书第一版所做出的贡献,对科学出版社的精心编辑一并表示感谢。

陈安民 徐永健

华中科技大学同济医学院附属同济医院

2005年5月

目 录

第一篇 总 论

第一章 妇产科病史记录要点	1
一、妇科病史记录要点	1
二、产科病史记录要点	3
三、计划生育病史记录要点	6
第二章 妇科诊断技术	9
一、妇科检查	9
二、生殖道分泌物检查	11
三、生殖道细胞学检查	12
四、生殖道活组织检查	15
五、诊断性刮宫	17
六、后穹隆穿刺	19
七、腹腔穿刺	20
第三章 产科诊断技术	22
一、产科检查	22
二、绒毛取样	25
三、孕中期羊水穿刺	27
四、脐带穿刺	29
五、胎心率电子监护	30
六、胎儿心电图	33
第四章 计划生育诊断技术	37
一、基础体温	37
二、输卵管通畅试验	38
三、子宫输卵管造影	40
四、精液检查	42
五、性交后试验	43

第五章 B超在妇产科的应用	44
一、B超在产科的应用	44
二、B超在妇科的应用	55
三、B超在计划生育的应用	62
四、多普勒监测胎儿脐血流	64
第六章 妇产科窥镜检查	68
一、阴道镜检查	68
二、宫腔镜检查	72
三、腹腔镜	74
四、羊膜镜	77
五、胎儿头皮血气分析	79
六、胎儿镜及宫内治疗	81
第七章 妇产科特殊检查	85
一、HCG测定	85
二、垂体激素测定	86
三、卵巢激素测定 (E.P.T)	87
四、胎盘激素测定	89
五、甲胎蛋白 (AFP) 测定	90
六、血浆内皮素的测定	91
七、CA 125测定	91
八、染色体检查	92
九、TORCH感染的检测方法	98
十、性传播疾病 (STD) 检测	99
十一、淋巴造影术在妇科肿瘤中的应用	100

第二篇 妇产科疾病

第八章 正常妊娠	103
一、妊娠诊断	103
二、围生期保健及监护	105
三、正常分娩的处理	111
四、产褥期的处理	114
五、正常新生儿的监护、喂养及处理	115

第九章 异常妊娠	118
一、妊娠剧吐.....	118
二、流产.....	120
三、异位妊娠.....	126
四、高危妊娠.....	130
五、妊娠高血压综合征.....	137
六、前置胎盘.....	142
七、胎盘早期剥离.....	145
八、早产.....	147
九、过期妊娠.....	149
十、羊水过多及过少.....	155
十一、胎儿宫内发育迟缓.....	157
十二、死胎.....	161
十三、多胎.....	163
十四、母儿血型不合.....	165
十五、脐带异常（先露、脱垂）.....	167
十六、胎膜早破.....	168
第十章 妊娠合并症	171
一、妊娠合并心脏病.....	171
二、妊娠合并病毒性肝炎.....	173
三、妊娠合并糖尿病.....	176
四、慢性肾炎.....	180
五、妊娠合并甲状腺功能亢进症.....	183
六、妊娠合并阑尾炎.....	187
第十一章 妊娠合并感染性疾病	190
一、TORCH 综合征.....	190
二、性传播疾病.....	203
三、其他妊娠合并感染.....	213
第十二章 异常分娩	216
一、产力异常.....	216
二、骨盆异常.....	219
三、胎儿异常.....	222

第十三章 分娩期并发症	231
一、产后出血	231
二、子宫破裂	234
三、羊水栓塞	237
四、子宫内翻	241
五、胎儿窘迫	243
第十四章 异常产褥	246
一、产褥感染	246
二、晚期产后出血	250
第十五章 新生儿疾病	253
一、新生儿复苏术	253
二、新生儿产伤	258
第十六章 外阴疾病	264
一、外阴瘙痒	264
二、慢性外阴营养不良	265
第十七章 女性生殖器炎症	269
一、外阴炎	269
二、前庭大腺炎	270
三、滴虫性阴道炎	272
四、真菌性阴道炎	274
五、细菌性阴道病	275
六、老年性阴道炎	277
七、幼女性阴道炎	278
八、宫颈炎	279
九、盆腔炎	282
十、女性生殖器结核	286
十一、淋病	288
十二、尖锐湿疣	291
十三、沙眼衣原体感染	293
第十八章 月经失调	295
一、功能失调性子宫出血病	295
二、闭经	301

三、多囊卵巢综合征·····	307
四、痛经·····	309
五、经前期紧张综合征·····	310
六、更年期综合征·····	312
第十九章 子宫内膜异位症与子宫腺肌病·····	315
一、子宫内膜异位症·····	315
二、子宫腺肌病·····	322
第二十章 女性生殖器官发育异常·····	325
一、处女膜闭锁·····	325
二、阴道发育异常·····	326
三、子宫发育异常·····	332
四、输卵管发育异常·····	338
五、卵巢发育异常·····	338
六、两性畸形·····	339
第二十一章 女性生殖道损伤性疾病·····	342
一、膀胱膨出（阴道前壁膨出）·····	342
二、直肠膨出（阴道后壁膨出）·····	343
三、子宫脱垂·····	344
四、生殖道尿瘘·····	346
五、生殖道粪瘘·····	349
第二十二章 外阴部肿瘤·····	351
一、外阴良性肿瘤·····	351
二、外阴上皮内瘤样病变·····	354
三、外阴浸润癌·····	355
四、阴道良性肿瘤·····	358
五、阴道腺病·····	359
六、阴道恶性肿瘤·····	361
第二十三章 子宫各部良恶性肿瘤·····	368
一、宫颈上皮内瘤样病变·····	368
二、宫颈浸润癌·····	371
三、宫颈复发癌·····	376
四、宫颈残端癌·····	377

五、子宫内膜上皮内瘤样病变	377
六、子宫肌瘤	380
七、子宫内膜癌	386
八、子宫肉瘤	390
第二十四章 卵巢肿瘤	394
一、良性卵巢肿瘤	394
二、恶性卵巢肿瘤	395
三、卵巢交界性肿瘤	402
第二十五章 输卵管肿瘤	403
一、输卵管良性肿瘤	403
二、输卵管恶性肿瘤	406
三、阔韧带内肿瘤	412
第二十六章 妊娠滋养细胞疾病	417
一、葡萄胎	417
二、侵蚀性葡萄胎	419
三、绒毛膜癌	421
第二十七章 不孕症	425

第三篇 妇产科手术

第二十八章 产科手术	427
一、会阴切开缝合术	427
二、人工破膜（剥膜）术	428
三、人工剥离胎盘术	429
四、胎头吸引术	430
五、产钳助产术	432
六、臀助产及臀牵引术	433
七、剖宫产	436
八、内倒转术	441
九、穿颅术及毁胎术	442
十、子宫内翻复位术	445
十一、会阴Ⅲ度破裂修补术	447

第二十九章 妇科手术	449
一、腹部手术前后处理.....	449
二、外阴、阴道手术前后处理.....	451
三、宫颈电熨、激光、微波治疗.....	452
四、LEEP 刀宫颈电切术.....	454
五、前庭大腺囊肿手术.....	455
六、无孔处女膜切开术.....	457
七、陈旧性Ⅲ度会阴裂伤修补术.....	458
八、外阴切除术.....	459
九、附件切除术.....	460
十、保守性输卵管手术.....	461
十一、卵巢楔形切除术.....	463
十二、子宫内膜异位症包块切除术.....	464
十三、子宫肌瘤剔除术.....	465
十四、腹式全子宫切除术.....	467
十五、腹式次全子宫切除术.....	469
十六、阴式子宫切除及阴道前后壁修补术.....	470
十七、皮瓣移植阴道成形术.....	473
十八、乙状结肠代阴道成形术.....	474
十九、妇科激光手术.....	477
第三十章 妇科肿瘤手术	484
一、外阴癌根治术.....	484
二、宫颈癌根治术.....	487
三、子宫体癌根治术.....	489
四、滋养细胞疾病子宫次全切除术.....	490
五、卵巢恶性肿瘤手术.....	491
六、盆腔肿瘤的再次手术.....	494

第四篇 计划生育

第三十一章 甾体类避孕药	496
一、短效避孕药.....	496

二、长效避孕药	499
三、长效避孕针	501
四、探亲避孕药	503
五、缓释长效避孕药	505
六、皮下埋植剂	506
七、阴道环放置	510
八、紧急避孕	510
第三十二章 宫内节育器	512
一、宫内节育器种类	512
二、宫内节育器放置	515
三、宫内节育器取出	521
第三十三章 人工流产	524
一、负压吸引术	524
二、钳刮术	525
三、人工流产并发症及其防治	527
第三十四章 药物流产	534
一、米非司酮配伍米索前列醇法	534
二、丙酸睾酮前列腺甲酯法	536
第三十五章 中期妊娠引产术	537
一、依沙吖啶羊膜腔内注射引产	537
二、依沙吖啶羊膜腔外注射引产	538
三、水囊引产	539
四、中期引产并发症的诊断及其防治	541
第三十六章 输卵管绝育术	545
一、经腹输卵管结扎术	545
二、腹腔镜输卵管绝育术	547
第三十七章 输卵管再通术	550
一、显微输卵管吻合术	550
二、经宫腔镜或宫腔镜—腹腔镜联合输卵管插管再通术	551
第三十八章 助孕技术	554
一、宫腔内授精 (IUI)	554

二、配子输卵管内移植技术 (GIFT)	557
三、体外受精及胚胎移植 (IVF-ET)	563
四、卵巢过度刺激综合征	566

第五篇 妇产科特殊治疗

第三十九章 性激素的应用	570
一、雌激素的应用	570
二、孕激素的应用	572
三、雄激素的应用	573
四、前列腺素在妇产科的应用	575
五、溴隐亭的应用	580
第四十章 围生期用药	582
一、孕妇用药的不良影响	582
二、药物对胎儿的致畸作用	582
三、围生期的用药原则	583
四、围生期用药的选择	584
第四十一章 促排卵用药	587
一、氯米芬	587
二、FSH 或 HMG/HCG 诱发排卵	588
三、溴隐亭	590
第四十二章 妇科恶性肿瘤的化学治疗	591
一、化学治疗	591
二、放射治疗	595
三、妇科恶性肿瘤的介入放射治疗	596
附 录	598
一、妇产科常用英文缩写	598
二、临床常用实验室检查正常参考值	608
三、妇产科内分泌激素测定参考正常值	615
四、华中科技大学同济医学院附属同济医院产科简化病史记录及分娩产程记录	620

第一篇 总 论

第一章 妇产科病史记录要点

一、妇科病史记录要点

病史和体检是诊断疾病的主要依据。疾病的正确诊断往往取决于准确、真实的病史采集。应了解各种症状发生的时间、前后关系，一般症状与特殊症状、全身情况及局部情况均应一一询问，以便进行分析、诊断。病史是规范化的医疗文书，在医疗、教学、科研、医疗纠纷调解处理工作中，其作用十分明显，无可替代。现将妇科病史记录要点分述如下。

（一）病史内容

1. 一般项目 患者姓名、性别、年龄、婚姻、职业、民族、籍贯或出生地、工作单位、住址、入院日期、病史记录日期、病史陈述者，要求填写完整。

2. 主诉 为患者就诊的主要症状。包括主要症状、部位、性质及时间。若有多种主要症状，则应按其发生的时间顺序、症状的轻重依次排列，如停经××日，阴道出血××日伴腹痛××日。症状不得用诊断名词。若患者无症状，系普查发现子宫肌瘤，主诉可写为：普查发现子宫肿块××日。

3. 现病史 此项主要说明主诉的情况，包括五个方面：

①起病情况：如起病时间，轻重缓急，发病原因或诱因。若无明显的发病原因或诱因，应注明。②主要症状：发生的部位、性质、程度及发展变化情况。③伴随症状：发生的时间、部位、特点、演变情况，与主要症状的关系，以及有鉴别诊断意义的阴性症状。④诊治经过：曾何时在何处做过何种重要检查和治疗以及结果和疗效。⑤发病以来的一般情况：如精神、食欲、大小便、睡眠和体重变化等情况。

4. 月经史 初潮年龄，经期持续时间/月经周期，每次经量多少（卫生纸或卫生巾的用量包数），有无血块，有无痛经及疼痛部位、性质、程度和起止时间。末次月经日期（LMP）和前次月经日期（PMP）。绝经者记录绝经年龄及绝经后有无阴道出血、排液等。

5. 婚育史 婚次及每次结婚年龄，是否近亲结婚，男方健康情况，同居情况，有无性病史。孕产史，如足月产、早产及流产次数，分娩情况，现存子女数。末次分娩或流产日期。采用何种计划生育措施及效果。

6. 既往史 以往健康情况。与本病有关的各种病史，特别是妇科疾病诊治简况。手术史和过敏史，若有应写明手术名称和时间，过敏为何种药物或何种致敏原及过敏情况。

7. 个人史 生长地，与本病有关的经历、职业、习惯、嗜好、接触史等。

8. 家族史 家庭主要成员的健康情况。家族成员中是否有类似病史，遗传病及传染病史。

（二）体检内容

1. 全身状况 体温、脉搏、呼吸、血压、发育、营养、神志、表情、体位、步态，全身皮肤及淋巴结，检查是否合作。必要时记录身高及体重。

2. 身体各部位、各主要系统的检查结果及描述。腹部检查及记录要详细。

3. 与鉴别诊断有关的阴性体征。

（三）妇科情况

1. 外阴 发育情况及婚产式。有无异常，如有应详细描述。

2. 阴道 是否通畅, 黏膜情况, 分泌物量、色、性状以及有无异味。

3. 宫颈 大小、长度、硬度, 有无糜烂(型、度)、裂伤、息肉、囊肿, 有无接触性出血、举痛, 宫颈口扩张及宫颈后方有无痛性结节等。

4. 宫体 位置、大小、形状、硬度、活动度, 有无压痛等。

5. 附件 有无肿块、增厚及压痛。若扪及块状物, 记录其位置、大小、形状、质地、表面光滑与否及活动度, 有无压痛以及与子宫和盆壁的关系。左、右两侧情况分别记录。三合诊要注明。

(四) 门诊资料

院内、外的主要化验及特殊检查的结果。应注明地点和日期。

(五) 病史小结

简明扼要地综合病史要点, 体检的阳性和有鉴别意义的阴性体征, 妇科检查的阳性体征, 门诊资料中的阳性结果。

(六) 诊断

主要诊断(病因、解剖、病理生理)。附属诊断包括并发症和合并症。

(七) 签名

病史记录者和审阅者必须签全名, 字迹易辨认。

(黎 宁)

二、产科病史记录要点

产科病历的书写是通过详细询问病史、认真体格检查, 特别是产科检查、各种辅助检查等方法对疾病进行调查研究、分析归纳, 在对产科常见病、多发病具有一定认识的基础上进行正确诊断的一种复杂过程。病历的撰写是其资料的记载、诊断的依据、治疗的指南, 故要求具有真实性、科学性、完整性、准确性、及时性, 且书写字迹工整, 力求医学用语, 严禁涂改。

(一) 书写产科病历的范围

1. 妊娠并发症 中度以上的妊娠高血压综合征(妊高

征)、前置胎盘、胎盘早剥、宫内发育迟缓(IUGR)、胆汁淤积综合征等。

2. 妊娠合并症 妊娠合并心脏病、慢性高血压、肾炎、肝炎、甲状腺功能亢进症(甲亢)、糖尿病、呼吸系统疾病、血液系统疾病。

(二) 病史采集的方法

医务人员采集病史时,应做到态度和蔼、语言亲切、耐心细致地询问,必要时给以启发,避免主观臆断。对以下特殊病人做到:

1. 对危重患者,在初步了解病情后,即行抢救,以免贻误治疗。病情缓解后再做补充。

2. 对外院转诊者,应向陪送人员(医务人员、家属、亲友)索阅院外病情、治疗、转归介绍作为重要资料。

3. 对有难言之隐者,既不可轻信,也不宜反复追问(性生活有关的问题),可通过妇科检查,了解是否有子宫增大,结合人绒毛膜促性腺激素(HCG),再做补充询问,即了解病情真相。

(三) 病史内容

1. 一般项目 包括姓名、性别、年龄、婚姻、职业、民族、籍贯、工作单位、住址、入院日期、记录日期、病史陈述者。

2. 主诉 简单明确地描述病人就诊时最主要的症状及最明显的体征和病程,一般要求通过主诉大致明确疾病方向,语言精练,≤20个字。如“孕38周,下肢水肿10天伴头昏眼花1天”、“孕35周,无痛性阴道出血3小时”。

3. 现病史 为病史的主体,应详加描述。一般先交代平素月经规则与否、停经多少天出现早孕反应、停经多少天感到胎动,然后包括患者最初发病至就诊期间病情的发生、发展、变化及诊疗的全部过程。一般以症状为主体,按时间先后顺序依次描述,产科特殊病史与症状、体征主要有:

(1) 阴道流血:需询问发生的孕周,出血为持续性、间断性或有无规律,出血量的多少、色泽、性状、有无血块,伴腹

痛与否，血压如何，并询问其诱因。

(2) 阴道流水：需询问阴道流水量的多少、性状，流水为持续性、间断性、多长时间，伴腹痛与否，且有无规律，或其他全身性变化，如发热等，并询问其他诱因。

(3) 血压升高：需询问孕前及家族中是否有高血压病史，是否有水肿、蛋白尿，伴头昏、眼花、胸闷与否及出现症状的先后、持续时间或其他全身症状。

说明发病以来精神、食欲、体重、发热、大小便情况。

4. 月经史 既往月经情况可按公式记录。

初潮年龄，行经天数/月经周期，末次月经时间和前次月经时间。

经量多少、颜色、性状。有无痛经及其性质、严重程度及持续时间。

5. 婚育史 结婚年龄，生育情况，如足月产 0 次，早产 1 次，人流 2 次，现有子女 0 人，可简写为 0-1-2-0（也可简写为孕 3 产 1）。孕期有无异常，分娩、产后有无并发症，末次分娩和流产时间，是否避孕绝育，采取何种措施或手术。

6. 既往史 指病人过去的健康状况和患病情况，特别是产科疾病、慢性高血压、肾炎、肝炎、糖尿病、贫血、心脏病等病史，外伤及手术史，过敏及预防接种史，输血及血液制品史。

7. 个人史 包括出生地、居留地、出差地、生活及饮食习惯，有无特殊嗜好（如烟酒），工作环境。

8. 家族史 重点询问家中主要成员有无与现病有关的遗传病史及传染病（肝炎、结核）或家族性疾病（高血压、糖尿病）。

（四）体格检查与产科检查

体格检查应在采集病史后进行。检查范围：全身、腹部、产科。检查要求：病人体位舒适，以防受凉；检查者手温适宜，手法轻柔正确，态度和蔼可亲；男医师检查要求第三者在场。

1. 全身检查 常规测量体温、脉搏、呼吸、血压、身高、

体重、发育、营养、体位、姿势、面容、神志、检查是否合作。全身皮肤、巩膜有无黄染，全身浅表淋巴结、头颅器官、颈、乳房、心、肺、脊柱、四肢。

2. 腹部检查 观察腹部隆起形状，腹壁有无瘢痕、妊娠纹、腹直肌分离等。触诊腹壁厚度，肝、脾、肾有无增大及压痛，腹部是否有压痛、反跳痛或肌紧张，能否触到包块。叩诊时注意鼓音或浊音分布范围，有无移动性浊音存在。检查脊柱四肢，神经反射，外阴肛门。

3. 产科检查 宫高（用 cm 表示；以耻骨联合上缘为起点，宫底最高处在腹中线上则以此为终点，否则以最高点向腹中线垂直靠拢交叉为终点）、腹围、胎心、胎方位、胎动。（检查前应排空膀胱）髂棘间径、髂嵴间径、骶耻外径、坐骨结节间径。如进入产程，则应查肛，了解宫颈管是否消失、宫颈口大小、软硬度、先露高低、破膜与否。

（五）病历小结

1. 一般项目 姓名、性别、年龄、职业。
2. 主诉。
3. 一般状态 生命体征、心肺情况、主要的阳性体征。
4. 产科检查。
5. 门诊资料。

初步诊断 1. 孕周待产或临产
2. 孕产
3. 胎方位
4. 妊娠并发症或合并症
依次排列
医师签全名
(冯 玲 黄引萍)

三、计划生育病史记录要点

计划生育病史书写要求分三种情况：一般引产病史填引产表格，特殊情况同产科病史；计划生育并发症同妇科病史；不

孕症病史则要求如下：

(一) 病史内容

1. 主诉 重点强调是原发或是继发性不孕及不孕年限。

2. 现病史

(1) 对原发性不孕重点询问患者的年龄、夫妻双方是否同居、性生活情况。

(2) 有关排卵情况：月经周期、初潮、量、痛经及末次月经。

(3) 继发不孕要追问既往妊娠经过、产褥期情况，重点询问有无发热、腹痛、阴道分泌物增多等感染征象。

(4) 不孕的特殊检查：基础体温、B超监测有无排卵、输卵管是否通畅、子宫内膜诊刮、腹腔镜检查等情况。性激素检测及卵巢储备功能检测情况等。

(5) 男方精液常规检查情况。

(6) 治疗经过：是否做过输卵管整形、吻合手术，以及是否接受过宫腔内受精（IUI）、配子输卵管内移植技术（GIFT）、体外受精（IVF）等助孕治疗，若有还要详细询问诱发排卵方案及卵巢的反应、卵泡的生长、卵子是否受精等情况。

3. 月经史 初潮年龄、月经周期、有无痛经、末次月经以及月经量改变等。

4. 婚育史 结婚年龄、既往孕产经过、末次妊娠时间和男方年龄、身体健康状况，有无吸烟、酗酒、吸毒等影响生育的不良嗜好。

5. 既往史 平素身体健康状况，重点询问结核史、盆腔炎、阑尾炎、腹腔手术史等。及有无甲状腺功能亢进症（甲亢）、甲状腺功能减退症（甲减）、垂体微腺瘤等影响生殖内分泌的疾病。

6. 个人史 强调有无吸烟、酗酒、吸毒等影响生育的不良嗜好。

7. 家族史 重点问女方的母亲、姊妹有无不孕、反复流产、月经稀发及卵巢早衰病史。

（二）体格检查

书写同妇科病史，但要强调如下几点：

1. 第二性征发育情况，是否女性体态。
2. 全身毛发分布状况，有无多毛、肥胖等。
3. 乳房发育情况，有无溢乳、泌乳。

（三）妇科检查的书写

同妇科病史。

（四）门诊资料及特殊检查

重点描述近期有关白带常规、B超检查、性激素水平，输卵管碘油造影、子宫内膜活检、腹腔镜检查的详细情况，精液分析结果。

（五）病史小结和诊断的书写

同妇科病史。

（朱桂金 艾继辉）

第二章

妇科诊断技术

一、妇科检查

妇科检查是妇产科的一种基本检查方法，是正确诊断妇科疾病的重要手段，包括腹部检查、外阴阴道检查、双合诊、三合诊及肛腹诊。通过视诊和触诊了解女性内、外生殖器的情况。

（一）检查前注意事项

1. 详细了解病情，对初次受检或精神过度紧张者应耐心解释，解除其思想顾虑和紧张情绪，取得患者的合作。
2. 检查前必须排空膀胱，必要时排空大便，以免误诊。
3. 月经期一般不做阴道检查，以免带进细菌而导致感染或引起子宫内膜异位。如有不正常阴道出血需做阴道检查时，应先消毒外阴，用消毒的润滑剂、窥器和手套检查。
4. 对未婚者禁做窥器检查及双合诊，限做肛腹诊。若确有必要，应先征得患者本人及家属同意后，方可进行。

（二）检查内容和步骤

1. 腹部检查 观察腹部外形，有无蛙腹或隆起。触诊如有肿块，注意其部位、外形、大小、软硬度、活动度、压痛等。然后叩诊注意有无移动性浊音。

2. 外阴阴道检查

（1）外阴部检查：观察外阴发育、阴毛多少和分布情况。有无畸形、水肿、皮炎、溃疡、赘生物或肿块。注意皮肤颜色、软硬度，有无增厚、变薄或萎缩。注意阴蒂长短，有无肥大、水肿、赘生物。未婚者处女膜多完整未破，经产妇的处女

膜仅留处女膜痕。检查时注意尿道旁腺和前庭大腺有无肿胀，若有脓性分泌物应涂片检菌和做培养。

(2) 窥器检查：观察阴道及宫颈情况。常用的为两叶窥阴器。若有条件应采用一次性窥阴器，避免交叉感染。

放置窥器时应将窥器两叶合拢，沾润滑剂，避开敏感的尿道口周围，沿阴道侧后壁缓慢斜插入阴道内，待窥器进入一半后，逐渐将两叶转平并张开，暴露宫颈及阴道壁和穹隆部。若取阴道分泌物或做宫颈刮片，宜用生理盐水作为润滑剂，以免影响检查结果。

检查阴道时应观察阴道壁黏膜的色泽、弹性及是否光滑，有无阴道隔或双阴道等先天畸形，有无溃疡、肿物、膨出、异物、瘘管，注意穹隆部有无裂伤，注意阴道分泌物的多少、性质、颜色、有无臭味等。

检查宫颈时应观察宫颈大小、颜色、外口形状，有无糜烂、撕裂、外翻、腺囊肿、息肉、肿块，有无宫颈延长、脱垂。

3. 阴道检查 主要检查阴道及宫颈。检查者戴消毒手套，食、中指沾润滑剂后轻轻进入阴道，在通过阴道口时，用食指和拇指扪触阴道口两侧有无肿块或触痛（如前庭大腺炎或囊肿存在）。然后进一步检查阴道的松紧度、长度，有无狭窄、瘢痕、结节、肿块、畸形（横隔、纵隔）以及穹隆部有无触痛、饱满，硬结。扪触宫颈时注意其大小、硬度，有无接触性出血。若拨动宫颈时患者感疼痛，称宫颈举痛。如怀疑宫颈管有肿瘤，则应伸一指入松弛的宫颈管内触摸。

4. 双合诊 阴道内手指触诊的同时用另一手在腹部配合检查称为双合诊。主要检查子宫及附件。

(1) 子宫：将阴道内手指放在前穹隆，另一手压下腹部，如两手间摸到子宫体，则为前位子宫。如在前穹隆未触及子宫体则将阴道内手指放在后穹隆，两手配合，如能摸到子宫体，则为后位子宫。检查时注意子宫的位置、大小、形状、软硬度、活动度及有无压痛，表面是否光滑等。

(2) 附件：将阴道内手指置于一侧穹隆，另一手移向同侧

下腹部，向下深压使两手能对合，以了解附件区情况。正常时输卵管不能扪及，而卵巢偶可扪及，应注意其位置、大小、软硬度、活动度以及有无触痛。若扪及肿块，应注意其位置、大小、形状、表面情况、活动度、囊性或实性、与子宫的关系。

5. 三合诊 腹部、阴道、肛门联合检查称为三合诊。一手食指放入阴道、中指放入直肠，另一手放置下腹部联合检查。三合诊的目的在于弥补双合诊的不足，主要借以更清楚地了解位于盆腔较后部及子宫直肠窝、子宫后壁、宫骶骨韧带、直肠阴道隔、主韧带、子宫颈旁、盆腔内侧壁以及直肠本身的情况。

6. 肛腹诊 一手食指伸入直肠，另一手在腹部配合检查，称为肛腹诊。一般适用于未婚、阴道狭窄或闭锁者。

二、生殖道分泌物检查

女性生殖道由于解剖和生理学特点，极易并发各种感染，故其分泌物的检查是妇科疾病临床常用而又十分重要的诊断方法。

（一）阴道清洁度的检查

1. 方法 棉拭子采取阴道分泌物，用生理盐水涂片，染色镜检，根据所见脓（白）细胞、上皮细胞、杆菌、球菌多少，分成Ⅰ～Ⅳ度（表 1-2-1）。

表 1-2-1 阴道清洁度判断表

清洁度	杆菌	球菌	上皮细胞	脓（白）细胞
Ⅰ	多	—	满视野	0～5/高倍视野
Ⅱ	少	少	1/2 视野	5～15/高倍视野
Ⅲ	少	多	少	15～30/高倍视野
Ⅳ	—	大量	—	>30/高倍视野

资料来源：卫生部医政司，全国临床检验操作规程 1990。

2. 临床意义

（1）Ⅰ～Ⅱ度为正常。Ⅲ～Ⅳ度为炎症。

(2) III~IV度者应注意做滴虫、念珠菌、衣原体或细菌学检查,以确定病原体指导治疗。

(二) 病原菌的检查

1. 涂片检查

(1) 滴虫和念珠菌检查:常用悬滴法,即放一滴温生理盐水于玻片上,取阴道后穹隆处的分泌物少许,混于温生理盐水中,立即在低倍镜下查找滴虫。滴虫呈梨形,有4根鞭毛,活动,比白细胞大2倍。同法镜下找芽孢及假菌丝,芽孢为卵圆形,假菌丝呈链状和分枝状,多为白色念球菌。

(2) 淋球菌检查:取尿道口、宫颈管分泌物涂片,晾干或以火焰烘干固定后,做革兰染色,并用1%藏红花复染,如在多核白细胞内找到典型肾形的革兰阴性双球菌6对以上,诊断即可成立。但是,有些形状相似的细菌,常常成双,有时也在细胞内出现,很难鉴别。必要时做培养确诊。

(3) 衣原体和支原体检查:常用直接免疫荧光法,采集宫颈分泌物或活体组织,立即涂片,采用直接免疫荧光法,在荧光显微镜下观察有无病原体,半小时可得结果。

2. 培养 生殖道分泌物(外阴、阴道、宫颈、尿道、附属腺、宫腔)可做细菌培养、淋球菌培养、念珠菌培养、衣原体及支原体培养,以提高诊断的可靠性。

三、生殖道细胞学检查

女性生殖道细胞包括来自阴道、宫颈及内生殖器的上皮细胞。阴道上皮细胞受卵巢激素的影响而有周期性变化。因此,检查阴道脱落细胞可反映体内性激素水平,是一种简便、经济、实用的辅助诊断方法,另一方面,阴道细胞学检查有助于早期发现女性生殖道的癌瘤。

(一) 标本的采集

采集标本所用器具必须清洁干燥。取材前24小时禁止性交、阴道检查、阴道灌洗及局部上药。为检查卵巢功能,要求至少1个月内不使用任何性激素。取材后,立即在清洁玻片上

向一致的方向涂布，注意厚薄适当，切忌来回涂抹，以防损伤细胞。涂片后立即固定于 95% 乙醇溶液中 15 分钟，待自然干燥。

1. 阴道壁涂片法 窥器扩张阴道，用清洁的刮板在阴道上 1/3 侧壁处刮取表面分泌物做涂片。

2. 后穹隆吸片法 窥器暴露宫颈，用吸管或棉拭子取后穹隆处分泌物做涂片。

3. 宫颈刮片法 暴露宫颈后，擦净表面分泌物，将特制小脚板的小脚部插入宫颈口，轻轻旋转一周，刮取鳞状及柱状上皮交界处细胞做涂片。

4. 宫颈管涂片法 用生理盐水浸湿的棉拭子插入宫颈管，轻轻旋转 2~3 周后涂片。用于检查宫颈管内的癌细胞。

5. 宫腔吸片法 常规消毒外阴、阴道后，窥器暴露宫颈并再次消毒，用塑料吸管或塑料刷等伸入宫腔，上下及左右移动，取材做涂片。可用于疑有宫腔恶性病变者。

（二）涂片的染色

一般采用巴氏（Papanicolaou）染色法或绍氏（Shorr）染色法，前者适用于癌细胞及卵巢功能的检查，染片中细胞透明度好，结构清晰，色彩鲜艳，但染色步骤较为复杂。后者染色简便，可用于卵巢功能的检查。在大数量防癌普查时常采用苏木精-伊红或湖蓝等简易染色法。

（三）正常阴道脱落细胞的形态特征

正常的阴道细胞涂片中可见复层扁平上皮细胞、柱状上皮细胞、间质细胞、非上皮细胞及微生物。阴道涂片检查主要观察复层扁平上皮的结构与变化。受雌激素的影响，复层扁平上皮由基底至游离面分为底层、中层及表层，逐渐趋向成熟。其形态变化规律为：细胞的体积由小变大；细胞核由大变小，最后固缩，甚至消失。柱状上皮细胞又可分为黏液细胞、带纤毛细胞两种，来自子宫颈管及子宫内膜。

（四）阴道细胞学的临床应用

1. 用于卵巢功能的检查 阴道脱落细胞受卵巢激素的影响，连续涂片检查能反映卵巢功能的动态变化，可协助诊断不

孕的原因、月经失调的类型以及随诊治疗效果。临床常用下列三种指数来表示体内雌激素水平。

(1) 阴道上皮细胞成熟指数：以阴道上皮细胞之底层、中层、表层所占百分数表示，若底层细胞增加表示雌激素水平下降，若表层细胞增加则表示雌激素水平升高。

(2) 角化指数：是指用复层扁平上皮细胞中的表层角化细胞的百分率来表示雌激素水平。

(3) 致密核细胞指数：是指复层扁平上皮细胞中的表层致密核细胞的百分率，指数愈高，表示上皮愈成熟，雌激素水平也愈高。

雌激素对阴道的影晌多以角化细胞指数为依据，在月经周期的卵泡期角化细胞占 20% 以下（轻度），在卵泡中期至排卵期占 20%~60%（中度），在病理性高雌激素水平或接受一定量雌激素治疗时角化细胞超过 60%。以上各指数可用于闭经、功能失调性子宫出血（功血）等疾病的诊治。

2. 用于妇科癌瘤的诊断 细胞学诊断的标准根据巴氏 5 级分类法，已普遍用于妇科的防癌普查。子宫颈癌的早期诊断率可达 90% 以上。采用宫腔吸片，子宫内膜癌的检出率高者可达 90%。然而涂片检查不能判明癌的部位及浸润程度，最后确诊仍需依靠活组织检查。

(1) 巴氏 5 级分类法

I 级（正常）：为正常的阴道细胞涂片。

II 级（炎症）：细胞核普遍增大，淡染或有双核，但无恶性证据。

III 级（可疑癌）：细胞核增大，染色加深，形状不规则或见双核。胞质少，异性程度较轻，但比 II 级为重，又称“核异质”或“间变细胞”。

IV 级（高度可疑癌）：细胞具有恶性特征，但数量少。

V 级（癌）：涂片中出现大量典型癌细胞。

(2) 各级涂片的处理：I 级或 II 级者，每 1~3 年定期复查。III 级者应进行复查，有炎症者给予治疗后复查。复查阴性后，每 3 个月定期检查，连续 3 次阴性时可延长至半年及一年

复查。若复查仍为Ⅲ级则应行阴道镜检查，酌情做宫颈及宫颈管活检。Ⅳ级或Ⅴ级者应及时做宫颈多点活检并注意自宫颈管取材，送病理检查确定诊断。

(3) 宫颈阴道细胞学计算机辅助检测系统 (computerized cytological test, CCT): 传统的宫颈阴道脱落细胞涂片技术出现假阴性结果的主要原因包括: 取材细胞真正用于涂片的仅约 20%, 即细胞丢失高达 80%; 炎性物及炎性细胞污染; 涂片厚薄不均匀, 随机性差。CCT 可以在相当程度上克服上述缺点, 避免因视觉疲劳和人为因素造成的检测误差。Thin Prep 技术 (即 TCT 检测) 给传统细胞学的制片技术带来了革命性的进展。该技术保证了取材的宫颈阴道细胞全部送检; 过滤系统可以减少涂片污染, 使涂片背景清洁; 涂片细胞薄层均匀分布, 图像更清晰。因此, 提高了宫颈阴道细胞学的诊断率。由于检查费用远较传统的巴氏涂片昂贵, 目前我国不能完全取代巴氏涂片检查。

四、生殖道活组织检查

生殖道活组织检查是自病灶或可疑病变部位取小部分组织做病理学检查, 常用的有外阴、宫颈及子宫内膜活组织检查。

(一) 外阴活组织检查

1. 适应证

(1) 确定外阴白色病变的类型及排除恶变。

(2) 外阴部赘生物或久治不愈的溃疡需明确诊断及排除恶变者。

2. 方法 患者取膀胱截石位, 常规外阴消毒, 局部浸润麻醉。小赘生物可自蒂部剪下或用活检钳钳取, 局部压迫止血。病灶面积大者行长 1cm, 宽 0.5cm 左右的梭形切口, 切除病灶部位的皮肤、皮下组织以及病灶周围的部分正常皮肤, 切口以细丝线缝合 1~2 针, 无菌纱布覆盖, 5 天后拆线。术后可给予抗生素预防感染。标本置于 10% 甲醛溶液固定后送病检。